

Αρ. Φακ.: 11.17.001.010.227

Απόφαση

Υπερβολική συλλογή δεδομένων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά την έκδοση Δελτίου Υγείας για το άθλημα του σκακιού

Αναφέρομαι στην καταγγελία που υποβλήθηκε στο Γραφείο μου, στις 13 Νοεμβρίου 2022, από τον ΧΧΧ (εφεξής ο «Καταγγέλλων») εναντίον του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (εφεξής ο «ΚΟΑ») και σε όλη τη σχετική με το ανωτέρω θέμα αλληλογραφία, η οποία αποτελεί μέρος των φακέλων της υπόθεσης. Βάσει των καθηκόντων και εξουσιών που μου απονέμουν τα Άρθρα 57 και 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Κανονισμός»), σημειώνω τα ακόλουθα:

A. Περιστατικά της υπόθεσης

2. Στην καταγγελία αναφέρονταν, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

- i. Ο ΚΟΑ απαιτεί την παραχώρηση λεπτομερών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας με σκοπό την έκδοση Δελτίου Υγείας για το πνευματικό άθλημα του σκακιού.
- ii. Συγκεκριμένα, για την έκδοση του Δελτίου Υγείας απαιτείται ιατρική εξέταση από καρδιολόγο, ιατρικό ιστορικό, κληρονομικό/οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και γενικές αναλύσεις αίματος. Ο Καταγγέλλων θεωρεί την συλλογή αυτή υπερβολική, ακατάλληλη και ξεκάθαρη παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού και ιδιαίτερα της αρχής της ελαχιστοποίησης.
- iii. Η έκδοση του Δελτίου Υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός σκακιστή σε διοργανώσεις της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και των τοπικών ομίλων σκακιού. Ως ισχυρίζεται ο Καταγγέλλων, ο ΚΟΑ δεν στηρίζεται σε κάποια επιστημονική βάση για την απαίτηση αυτή, ούτε σε κάποια ευρωπαϊκή ή διεθνή πρακτική.

- iv. Ο Καταγγέλλων εκλαμβάνει την συγκεκριμένη προϋπόθεση ως εξαναγκασμό παραχώρησης προσωπικών δεδομένων.
- v. Ο Καταγγέλλων απευθύνθηκε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΚΟΑ ζητώντας όπως εξεταστεί κατά πόσο οι διατάξεις/αποφάσεις που αφορούν στην έκδοση των Δελτίων Υγείας πληρούν τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό, αλλά η απάντηση που έλαβε δεν τον ικανοποίησε.

3. Μαζί με το έντυπο παραπόνου, ο Καταγγέλλων απέστειλε στο Γραφείο μου, την αλληλογραφία που αντάλλαξε με τον Υπεύθυνο Προστασίας του ΚΟΑ, τα έντυπα «*Ιατρική εξέταση για Δελτίο Υγείας*» και «*Επιστροφή Εντύπου «Ιατρική Εξέταση για Δελτίο Υγείας*»».

4. Για τη διερεύνηση της καταγγελίας, το Γραφείο μου απέστειλε στις 9 Δεκεμβρίου 2022, σχετική επιστολή στον ΚΟΑ, μέσω της οποίας γνωστοποίησε την υποβολή του παραπόνου εναντίον του και ζήτησε τις θέσεις του όσον αφορά στους ισχυρισμούς που έθεσε ο Καταγγέλλων. Στις 9 Ιανουαρίου 2023, παραλήφθηκαν οι αρχικές θέσεις του ΚΟΑ στις οποίες δηλώνονταν, ανάμεσα σε άλλα, τα κάτωθι:

- i. Το Δελτίο Υγείας ΚΟΑ και ο προαθλητικός έλεγχος αποτελούν δικλείδα ασφαλείας των αθλουμένων κάθε ηλικίας, οποιουδήποτε αθλήματος.
Σκοπός της έκδοσης του Δελτίου Υγείας Αθλητών είναι -
 - η πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου στους αθλουμένους κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης,
 - η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή με περιορισμό αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση.
- ii. Για τον καθορισμό των ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων και της εν γένει απαιτούμενης ιατρικής διαδικασίας έχει συσταθεί, δυνάμει των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ (άρθρο 5(ιστ) του Ν. 41/1969), 5μελής Επιστημονική Επιτροπή Ανωτάτου Συμβουλίου Υγείας Αθλητών (εφεξής η «Επιτροπή ΑΣΥΑ»).
- iii. «*Το Δελτίο Υγείας Αθλητών ΚΟΑ (το οποίο εκδίδεται σε πλαστική κάρτα) είναι υποχρεωτικό και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλητών/τριων ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου, κατηγορίας και αθλήματος σε προπονήσεις και αγώνες των αναγνωρισμένων Αθλητικών Σωματείων και Αθλητικών Ομοσπονδιών. Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες έχουν την απόλυτη ευθύνη του ελέγχου της ισχύος του Δελτίου Υγείας των αθλητών/τριων και ως εκ τούτου προσκομίζεται υποχρεωτικά στην γραμματεία και/ή στον αρμόδιο διαιτητή/τες και /ή παρατηρητή/τες, κάθε είδους αγώνα και, αθλητικής εκδήλωσης, σύμφωνα με τους*

κανονισμούς και τις προκηρύξεις αγώνων των αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών»

- iv. «Η έκδοση Δελτίων Υγείας διέπεται από τον περί ΚΟΑ Νόμο του 1969 (41/69 Μέρος Τρίτον, σημεία στ και κ), καθώς επίσης και τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις διαδικασίες και τις εγκυκλίους που εκδίδει το Τμήμα Δελτίων Υγείας, κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ. Επομένως η συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων (ιατρικών και μη) όλων των αιτητών για έκδοση Δ.Υ. αποτελούν συμμόρφωση του Οργανισμού ως αναφέρετε στα Άρθρα 6.1.γ και Άρθρο 9.2.η του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ.
- v. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος, και συγκεκριμένα το άρθρο 5. 2 (του «ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», έχει συστήσει την Επιστημονική Επιτροπή Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ), η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων, και της εν γένει απαιτούμενης ιατρικής διαδικασίας για την υποβολή αίτησης και αξιολόγησης της για έκδοση Δελτίου Υγείας Αθλητών ΚΟΑ. Η Επιτροπή ΑΣΥΑ κατόπιν συναντήσεων και διαβούλευσης με την ΚΥΣΟ, στην συνεδρία της ημερομηνίας 08/04/2021, η οποία επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού (23/06/2021), αποφάσισε όπως τροποποιήσει τις ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις των αθλουμένων της ΚΥΣΟ, καθώς επίσης και άλλων πνευματικών αθλημάτων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 34ο έτος της ηλικίας τους(...)»
- vi. «Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την αίτηση και αξιολόγηση για έκδοση Δελτίου Υγείας (συμπεριλαμβανομένων των Γονικών Συναινέσεων, Εξουσιοδοτήσεων και έντυπων Παραλαβής), διατηρούνται μέχρι και έξι (6) μήνες από την λήξη του εκδομένου Δελτίου Υγείας εφόσον δεν υφίστανται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μερών ή/και εφόσον δεν υφίσταται οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου ή/και δικαστική διαδικασία που αφορά ή σχετίζεται με την υπόθεση. Επίσης, διαγραφή των προσωπικών δεδομένων γίνεται αυτόματα με την έγκριση και έκδοση νέου Δελτίου Υγείας ή σε περίπτωση που η αίτησή σας καταχωρηθεί ως εκκρεμότητα για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.
- Το πιο πάνω ισχύει και στις περιπτώσεις που έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης και υποβολής:
 - Του εντύπου «Ιατρική Εξέταση για έκδοση Δελτίου Υγείας», των ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων καθώς επίσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών για έκδοση Δελτίου Υγείας.
 - Των συμπληρωματικών/παραπτεμπτικών εξετάσεων που απαιτήθηκαν από την Ιατρική Επιτροπή.

- Όλων των βεβαιώσεων και δικαιολογητικών που έχουν απαιτηθεί από το Τμήμα για την περαιτέρω αξιολόγηση και χειρισμό της αίτησης.
- vii. «(...) το Δελτίο Υγείας Αθλητών ΚΟΑ και ο προαθλητικός έλεγχος αποτελούν δικλείδα ασφάλειας για την συμμετοχή των αθλουμένων κάθε ηλικίας, που ασχολούνται τακτικά, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, με οποιοδήποτε είδος άθλησης.»

5. Στην πιο πάνω απάντηση επισυνάφθηκαν επιστολή από τον Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής ΑΣΥΑ ημερ. 28 Δεκεμβρίου 2022, πίνακας απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων και δικαιολογητικών για έκδοση Δελτίου Υγείας, αντίγραφο του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 (41/1969).

6. Σύμφωνα με την Επιτροπή ΑΣΥΑ, της οποίας οι θέσεις έχουν αναλυθεί στην επιστολή της ημερ. 28 Δεκεμβρίου 2022:

- i. Ο ΚΟΑ είναι η Ανώτατη Αθλητική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρμόδια για την έκδοση Δελτίων Υγείας των Αθλητών.
- ii. Η αποστολή του ΚΟΑ μέσω της έκδοσης των Δελτίων Υγείας είναι η πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου στους αθλουμένους, κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης, καθώς επίσης και της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης των παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή με περιορισμό αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση.
- iii. Στόχος των Δελτίων Υγείας είναι η υποβολή όλων των αθλουμένων ανεξαρτήτως ηλικίας ή αθλήματος, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά ή ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό σε ένα προκαθορισμένο ιατρικό έλεγχο ο οποίος αποσκοπεί στην ανίχνευση προβλημάτων υγείας τα οποία ενδεχομένως να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή τους όχι μόνο κατά την άσκηση, αλλά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.
- iv. Για τον καθορισμό των απαραίτητων ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων των αθλουμένων, η Επιστημονική Επιτροπή ΑΣΥΑ έχει λάβει υπόψη της την σχετική βιβλιογραφία, τις επιστημονικές και ερευνητικές βάσεις δεδομένων, όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστάσεις και τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες των παγκοσμίων και ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν στον προαθλητικό και παθολογικό ιατρικό έλεγχο.
- v. Η Επιτροπή ΑΣΥΑ, μετά από συναντήσεις με τις ομοσπονδίες πνευματικών αθλημάτων, ανάμεσα τους και με την Σκακιστική ομοσπονδία παρουσία του Ιατρού καρδιολόγου της, και κατόπιν μελέτης, έχει συμφωνήσει και αποφασίσει τις προαπαιτούμενες εξετάσεις κατά την υποβολή της αίτησης έκδοσης Δελτίου Υγείας αθλουμένων που συμμετέχουν σε πνευματικά αθλήματα.

- vi. Οι ερωτήσεις και οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο αθλούμενος για την έκδοση του Δελτίου Υγείας, έχουν ως στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και τον αποκλεισμό των σοβαρών αιτιών που δυνητικά θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή κατά τη συστηματική άσκηση και/η δραστηριότητα.
- vii. Οι εξετάσεις για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, έχουν καθοριστεί για τα πνευματικά αθλήματα, με απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής ΑΣΥΑ, μετά από συναντήσεις με την Σκακιστική Ομοσπονδία, παρουσία του Ιατρού καρδιολόγου της.
- viii. *«Κάθε χώρα διαμορφώνει την οικεία Νομοθεσία σε συνεννόηση με την αρμόδια θεσμική αρχή αθλητισμού σχετικά με τον προαθλητικό έλεγχο για την συστηματική συμμετοχή τους σε αγώνες και δραστηριότητες. Η Κύπρος θεωρείται από τις πρωτοπόρες στον τομέα της πρόληψης αιφνιδίου θανάτου (...) με πολυετή εμπειρία στον προαθλητικό έλεγχο.»*
- ix. Το θέμα έχει συζητηθεί και με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, στην οποία αναλύθηκε και τεκμηριώθηκε από ΚΟΑ και Επιτροπή ΑΣΥΑ η σημαντικότητα του προαθλητικού ελέγχου και η πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου και της έκδοσης του Δελτίου Υγείας για την πρόληψή του, ανεξαρτήτως του είδους της δραστηριότητας (σωματικής ή πνευματικής).
- x. Η Επιτροπή ΑΣΥΑ καταλήγει στην επιστολή ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2022 ότι *«Σε ουδεμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων. Η διαδικασία εμπίπτει στις πρακτικές εξάσκησης της Ιατρικής. Η καταγραφή των παθολογικών ευρημάτων διαμορφώνει Τράπεζα δεδομένων για σκοπούς έρευνας προς όφελος της αξιόπιστης στατιστικής και διαμόρφωσης μητρώου περιστατικών, τηρώντας τους κανόνες της επιτροπής βιοηθικής. Η άντληση παθολογικών δεδομένων θα συμβάλει στην βελτίωση των πρακτικών που ακολουθούνται στην πρόληψη του ΑΚΘ αλλά και την μεγιστοποίηση των συνθηκών διασφάλισης της ζωής των πολιτών/αθλουμένων.»*

7. Μετά την λήψη των πιο πάνω θέσεων, το Γραφείο μου απευθύνθηκε ξανά προς τον ΚΟΑ στις 3 Φεβρουαρίου 2023, εκφράζοντας κάποιες αρχικές απόψεις επί του θέματος και ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στον ισχυρισμό του ΚΟΑ ότι οι ιατρικές εξετάσεις οι οποίες ο ΚΟΑ απαιτεί για την έκδοση Δελτίων Υγείας είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά/διεθνή πρότυπα ή/και οδηγίες και δεν είναι περισσότερες από αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση του σκοπού της έκδοσης. Στις 17 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή ΑΣΥΑ δήλωσε τα πιο κάτω:

- i. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, ο προαθλητικός έλεγχος έχει σαν στόχο την πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου κατά τη διάρκεια της άσκησης και τη διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων που δεν επιτρέπουν την άθληση. Πρόκειται για ένα καρδιολογικό έλεγχο που γίνεται πριν την έναρξη κάποιας αθλητικής δραστηριότητας για επαγγελματικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους. Για να αποκλειστεί

ακόμα και η παραμικρή πιθανότητα τέτοιου περιστατικού, ζητείται προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος πριν την συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

- ii. Πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου με την εφαρμογή προαθλητικού καρδιαγγειακού ελέγχου συνίσταται από την Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία.
- iii. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας θεωρούν απαραίτητη στον προαθλητικό έλεγχο τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και την προσεκτική ερμηνεία του, μαζί με την λήψη ιστορικού και την φυσική εξέταση.
- iv. Η ανίχνευση των καρδιακών νοσημάτων σε αθλητές απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένου πρωτοκόλλου διαλογής, στο οποίο προεξάχοντα ρόλο έχει το ατομικό και κληρονομικό ιστορικό, ή κλινική εξέταση και το καρδιογράφημα.
- v. Για τον καθορισμό της ιατρικής διαδικασίας μελετήθηκαν:
 - α. Το «Βοήθημα για την αξιολόγηση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε νέους & αθλητές» και η αναφερόμενη σε αυτό βιβλιογραφία,
 - β. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας,
 - γ. Η Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας ημερ. 3/8/2018 με Θέμα «Κάρτα Υγείας Αθλητή»,
 - δ. Τα ευρήματα του 42^{ου} Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου,
 - ε. Άλλες βιβλιογραφικές πηγές (π.χ. Eur Heart J 2005, European Journal of Preventive Cardiology 2017).
- vi. Σε όλα τα πνευματικά αθλήματα, για αθλητές ηλικίας άνω των 34 ετών είναι αρκετή, για σκοπούς έκδοσης Δελτίου Υγείας, η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (Έντυπο Ιατρικής Εξέτασης για έκδοση Δ.Υ.), ΗΚΓ με γνωμάτευση, αναλύσεις αίματος κ.α., κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί με την σκακιστική Ομοσπονδία, παρουσία του καρδιολόγου της, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα για τα οποία απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις.

Συνημμένα στην πιο πάνω απάντηση ήταν η Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας ημερ. 3/8/2018 με Θέμα «Κάρτα Υγείας Αθλητή», το πρόγραμμα του 42ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου και αντίγραφο του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1969 (41/1969).

8. Στις 15 Μαρτίου 2023, ο Καταγγέλλων ενημερώθηκε για τα πιο πάνω και για κάποιες εκ πρώτης όψεως θέσεις μου και στις 17 Μαρτίου και 12 Μαΐου 2023 δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

- i. *«Φαίνεται όμως ότι έχετε βασιστεί εξολοκλήρου σε πληροφορίες και γνωματεύσεις που σας έχει παρέχει ο ίδιος ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία, στο νομικό υπόβαθρο που υπάρχει και δεν έχετε πραγματοποιήσει ανεξάρτητη έρευνα όπως για παράδειγμα αναζητώντας τη σύμφωνη γνώμη ανεξάρτητου ιατρικού εμπειρογνώμονα ή την άποψη απόμων και*

οργανισμών που δεν εμπλέκονται άμεσα. Οι όποιοι ανεξάρτητοι μπορεί βέβαια να συμφωνήσουν με το ΑΣΥΑ αλλά δεν φαίνεται να αναζητήσατε μια επιβεβαίωση των αποφάσεων της ΑΣΥΑ και τις λάβατε ως δεδομένες και υπεράνω κάθε αμφισβήτησης. (...) Παρά ότι ο Κυπριακός νόμος παραχωρεί στο ΑΣΥΑ τις σχετικές δυνατότητες, αυτός ο έλεγχος πιστεύω ήταν εύλογο να διενεργηθεί δεδομένου ότι για το σκάκι - σε αντίθεση με άλλα σωματικά αθλήματα - δεν αποτελεί συνήθης πρακτική σε άλλες χώρες της Ε.Ε. να απαιτούνται τέτοιου είδους δεδομένα και εξετάσεις.»

- ii. Η Απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας ημερ. 3/8/2018, έχει τροποποιηθεί. Με μεταγενέστερο αθλητικό νόμο, τον 4726/2020, άρθρο 12 παράγραφος 9, οι σκακιστές εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Επί λέξη, ο αθλητικός νόμος αυτός αναφέρει: "Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρίκιου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες." (το ζατρίκιο είναι μια παλαιότερη ελληνική λέξη για το σκάκι).
- iii. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη προκήρυξη των πανελλήνιων ατομικών πρωταθλημάτων νέων ανδρών - νέων γυναικών (ημερομηνία δημοσίευσης 3/3/2023 - <https://www.chessfed.gr/archives/11744>), επιβεβαιώνει τη σχετική ρύθμιση αναφέροντας επί λέξει: "Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο, ανανεωμένο – ενεργοποιημένο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ. Διευκρινίζεται ότι το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας θεωρείται ανανεωμένο – ενεργοποιημένο αν έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος ανανέωσης – ενεργοποίησης (10 €) ή το τέλος εγγραφής που καταβάλλεται για την έκδοση νέου Δελτίου (νέα εγγραφή – έκδοση από 1/1/ 2023 και μετά). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα το άρθρο 12 του ν. 4726 (ΦΕΚ 181 Α΄ 18/9/2020) οι σκακιστές εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτα υγείας ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες."
- iv. Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία συλλέγει πολύ λιγότερα στοιχεία για εγγραφή του αθλητή σε σχέση με αυτά που απαιτεί ο ΚΟΑ από τους Κύπριους σκακιστές μέσω της έκδοσης του Δελτίου Υγείας.
- v. Ο Καταγγέλλων έθεσε επίσης το ερώτημα «Οποιοσδήποτε ιατρικές εξετάσεις είναι πάντοτε χρήσιμες αφού κάτι μπορεί να δείξουν κάποια παθογένεια και να προλάβουν, αλλά πότε μπορεί να δικαιολογηθεί το κόστος τους για τους σκοπούς που γίνονται;» Ως αναφέρει, το κόστος των ιατρικών εξετάσεων το επωμίζονται οι αθλητές και οι οικογένειες τους και όχι ο ΚΟΑ ή το ΓΕΣΥ - αφού αν αναλάμβανε το κράτος αυτό το κόστος ενδεχομένως να γινόταν εξέταση του θέματος σε μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρεια και τα συμπεράσματα να ήταν διαφορετικά.

- vi. Λόγω της σχετικής έλλειψης συγκεκριμένης βιβλιογραφίας και μελετών που να αφορούν στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα πνευματικά αθλήματα ο Καταγγέλλων έθεσε στις 23 Απριλίου, 2023 τα εξής ερωτήματα στην διαδικτυακή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT «*Is pre participation screening necessary for chess?*» και «*Is pre participation screening necessary for American football?*» Από τις απαντήσεις που έλαβε, τις οποίες παρέθεσε στην επιστολή του, κατέληξε ότι: «*Συνοψίζοντας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι ειδικός, η άποψη του ΑΣΥΑ για τις ιατρικές εξετάσεις που χρειάζονται για το σκάκι και τα πνευματικά αθλήματα, φαίνεται ότι δεν υιοθετείται γενικότερα, όχι μόνο στην αγωνιστική πράξη του σκακιού στο εξωτερικό αλλά ούτε και από πολλούς γιατρούς-καρδιολόγους και ούτε και από εργαλεία έρευνας όπως το ChatGPT.*»
- vii. Φαίνεται ότι η μη εφαρμογή του Δελτίου Υγείας από κάποια ομοσπονδία που ανήκει στον ΚΟΑ μπορεί να έχει σοβαρότατες συνέπειες όπως τον δραστικό περιορισμό των κονδυλίων που παραχωρούνται σε μια ομοσπονδία μέχρι και την αποχώρηση από τον ΚΟΑ. Για την ομοσπονδία του σκακιού, ενδεχόμενη άρνηση ίσως θα έφερε και οικονομικό στραγγαλισμό, αδυναμία να χρηματοδοτήσει εθνικές αποστολές στο εξωτερικό κλπ. Έτσι, η Ομοσπονδία είχε να συνυπολογίσει πιθανότατα και άλλους παράγοντες στην απόφαση της να συμμορφωθεί με το μέτρο και όχι μόνο τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων ελέγχων για το άθλημα.
- viii. Πρόσθετα με τα πιο πάνω, για την παραχώρηση Δελτίου Υγείας απαιτούνται στρατολογικά στοιχεία και απολυτήριο στρατού ακόμη και για τα πνευματικά αθλήματα. Η ιστοσελίδα του ΚΟΑ που σχετίζεται με το Δελτίου Υγείας <https://cyprussports.org/health-journal/> περιέχει αρκετά έντυπα που συνδέουν το Δελτίο Υγείας με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων - σε περίπτωση βέβαια που κάποιος άρρενας βρίσκεται σε ηλικία που έπρεπε να καταταχθεί, σε αντίθεση με την λιτή φόρμα που χρειάζεται να συμπληρωθεί για έκδοση κάρτας αθλητή της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.
- ix. «*Αντικειμενικά νομίζω είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η συγκεκριμένη απαίτηση του Οργανισμού για την προσκόμιση στρατολογικών στοιχείων σε σχέση με τα πνευματικά αθλήματα - πέραν του ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια κινήτρου (ή απειλής) για κάποιον να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Βέβαια δεν αμφισβητώ ότι αυτό γίνεται μέσα στο νομικό πλαίσιο που έχει εγκριθεί. Είναι άξιο απορίας όμως, το πού σταματά το δικαίωμα του Οργανισμού και του κράτους να ζητά στοιχεία άσχετα με το σκοπό που χρειάζονται. Δηλαδή αν στο μέλλον ζητηθούν από τον ΚΟΑ λευκό ποινικό μητρώο (σε προσπάθεια για παράδειγμα να αποκλειστούν οι πρώην εγκληματίες από τον αθλητισμό με σκοπό τη μείωση της βίας) ή απόδειξη ότι ο αθλούμενος έχει εκπληρώσει πλήρως τις φορολογικές του υποχρεώσεις (σε προσπάθεια να παταχθεί η φοροδιαφυγή), επίσης θα είναι συμβατά με τον κανονισμό που το γραφείο σας ορίστηκε να προστατεύει;»*

- χ. «(...) θέλω να παρατηρήσω ότι υπάρχει μια ασυμμετρία μεταξύ της εφαρμογής των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον δημόσιο τομέα και για τον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα, οι πλείστες ενέργειες και εξουσίες πηγάζουν από την Βουλή και την Εκτελεστική εξουσία, με τη μορφή νομοθεσιών. Ένας τρόπος για να απαντηθεί το παράπονο μου είναι ότι η συγκεκριμένη πρακτική του ΚΟΑ "Είναι σωστή επειδή είναι νόμος" και "Ο νόμος είναι νόμος επειδή είναι σωστός". Είναι με άλλα λόγια ένα κυκλικό επιχείρημα. Δηλαδή ακόμη και πρακτικές που ίσως θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν και που ενδεχομένως είναι αντίθετες με ορισμένες γενικότερες αρχές, επειδή καλύπτονται από το πέπλο της νομιμότητας, δεν σηκώνουν αμφισβήτηση. Αντίθετα, στον ιδιωτικό τομέα, οι μέτοχοι, γενικές συνελεύσεις, διοικητικά συμβούλια και εκτελεστικοί διευθυντές, αποφασίζουν για τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών τους αυτόνομα και δεν χρειάζονται οι αποφάσεις τους να εγκρίνονται από την Βουλή και την Εκτελεστική εξουσία με τη μορφή νέων νόμων. Έτσι, αφού δεν καλύπτονται από το πέπλο της νομοθεσίας, είναι πιο εύκολο και να αμφισβητηθούν και οι ιδιωτικοί οργανισμοί να βρεθούν υπόλογοι για τις πράξεις και παραλήψεις τους».

9. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω θέσεις του Καταγγέλλοντος, το Γραφείο μου απευθύνθηκε με σχετικό ερώτημα, προς τις εποπτικές αρχές της Πορτογαλίας, Μάλτας, Ελλάδας, Ιρλανδίας και Ιταλίας σχετικά με τις διαδικασίες/κανόνες προ-αθλητικού ελέγχου στο σκάκι (κατά πόσο απαιτείται η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού υγείας και ποια δεδομένα συλλέγονται), έτσι ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα. Οι Εποπτικές Αρχές προστασίας δεδομένων της Ελλάδας, Ιρλανδίας και Μάλτας επιβεβαίωσαν ότι δεν ζητούνται ιατρικά δεδομένα ή διεξάγεται ιατρικός έλεγχος για την έκδοση οποιουδήποτε ιατρικού πιστοποιητικού, έτσι ώστε οι σκακιστές να μπορούν να λάβουν μέρος σε επίσημες διοργανώσεις. Η Εποπτική Αρχή της Ιταλίας ανέφερε ότι, συγκεκριμένες νομοθετικές πρόνοιες υπάρχουν μόνο για τους «*masters professionals*», επισημαίνοντας φυσικά ότι η FSI - Italian Chess Federation είναι μέλος του CONI (ιταλικός ολυμπιακός οργανισμός), επομένως υλοποιεί και εφαρμόζει όλες τις οδηγίες της, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων δεοντολογίας για θέματα κατά του ντόπινγκ. Τέλος, η Εποπτική Αρχή της Πορτογαλίας σημείωσε επίσης τον Anti-doping Regulation, βάσει του οποίου οι αθλητές δυνατόν να υπόκεινται περιοδικά σε ελέγχους υπογραμμίζοντας ότι η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να διέπει την οποιαδήποτε έκδοση πιστοποιητικού υγείας, δηλαδή το πιστοποιητικό να είναι ανάλογο του αθλήματος στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί/ για το οποίο εκδίδεται.

10. Μετά την λήψη των πιο πάνω θέσεων, στις 28 Φεβρουαρίου 2024, εξέδωσα την Εκ πρώτης όψεως Απόφαση, στην οποία διαπίστωσα εκ πρώτης όψεως παραβίαση του Άρθρου 5(1)(γ) του Κανονισμού από τον ΚΟΑ, και έκρινα ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθεί κατά πόσο χρειάζεται η έκδοση Δελτίου Υγείας για τους αθλητές στο

σκάκι και αν ναι, να τεκμηριωθεί αν τα συλλεχθέντα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα συναφή και ελάχιστα υπακούοντας την αρχή της αναλογικότητας. Στις 10 Απριλίου 2024, έλαβα τις θέσεις του ΚΟΑ όσον αφορά στην εν λόγω Απόφαση.

11. Σύμφωνα με τον ΚΟΑ:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει η οικεία νομοθεσία (άρθρο 5.2. (ιστ), (ιζ) και (κ) του Νόμου (41/69), έχει συστήσει την Επιστημονική Επιτροπή Ανώτατου Συμβουλίου Υγείας Αθλητών (ΕΕ ΑΣΥΑ) και τις Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης των αθλητών (ΙΑΕ).

2. Σημειώνεται ότι κάθε αθλητής αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή σωματείου ο οποίος προπονείται και αγωνίζεται συστηματικά, ερασιτεχνικά και/ή επαγγελματικά, υποχρεούται να κατέχει Δελτίο Υγείας. **Σκοπός του Δελτίου Υγείας και των εξετάσεων που διενεργούνται προς έκδοση του είναι η πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου σε αθλούμενους. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή με περιορισμό αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση.**

3. Η ΕΕ ΑΣΥΑ σύμφωνα με τους όρους εντολής της υπέχει μεταξύ άλλων «[...] την ευθύνη τού καθορισμού των ιατρικών και παρακλινικών εξετάσεων και της εν γένει απαιτούμενης ιατρικής διαδικασίας για την υποβολή αίτησης για έκδοση Δελτίου Υγείας Αθλητών ΚΟΑ».

4. Περαιτέρω και κατόπιν εισηγήσεων της ΕΕ ΑΣΥΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έχει συστήσει ως υποεπιτροπές, τις Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΙΑΕ), οι οποίες συνεδριάζουν και ελέγχουν και αξιολογούν δευτερογενώς, τις ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις που προσκομίζουν οι αθλητές/τριες που επιθυμούν την έκδοση Δελτίου Υγείας και εγκρίνουν την έκδοση Δελτίου Υγείας καθώς επίσης και την διάρκεια ισχύος τους.

5. Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός κατόπιν των συστάσεων της ΕΕ ΑΣΥΑ, όλοι/ες οι αθλητές/τριες οι οποίοι επιθυμούν την έκδοση Δελτίου Υγείας ΚΟΑ θα πρέπει να εξεταστούν πρωτοβάθμια από Ιατρό της επιλογής τους και να προβούν στον απαραίτητο προαθλητικό ιατρικό και καρδιολογικό έλεγχο.

6. Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥΣΟ) ως αναγνωρισμένη Αθλητική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 (Ν.41/69) ως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, καθώς επίσης και τις ερμηνείες που περιέχονται στο άρθρο 2 της νομοθεσίας (αγώνας, άθλημα, κ.α.) έχει την υποχρέωση συμμόρφωσης με και εφαρμογής όλων των κανονισμών και αποφάσεων που εκδίδονται από τον ΚΟΑ, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης Δελτίου Υγείας ΚΟΑ. **Αθλητισμός και Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος**

7. Ο αθλητισμός και η άσκηση πέρα από τα αναντίρρητα οφέλη τους, μπορούν να αποτελέσουν πηγή δημιουργίας προβλημάτων υγείας κυρίως από το καρδιαγγειακό

σύστημα με κορυφαίο τραγικό γεγονός τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (ΑΚΘ). Ειδικά ο θάνατος ενός αθλητή αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συνολική κοινωνική συνείδηση, καθώς οι αθλητές προσωποποιούν την επιτομή του σφρίγγους και της υγείας.

8. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι η πιο συχνή αιτία μη τραυματικού θανάτου στους αθλητές. Σε μεγάλη μελέτη του Corrado και των συνεργατών του¹, έχει υπολογιστεί ότι η συμμετοχή σε αγωνιστικό αθλητισμό αυξάνει κατά 2.5 φορές τον κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε σχέση με άτομα που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό.

9. Επιδημιολογικά δεδομένα έχουν δείξει ότι τα αίτια του ΑΚΘ διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία. Για τους αθλητές ηλικίας < 35 ετών, τα πιο συχνά αίτια ΑΚΘ είναι τα Κληρονομικά Καρδιαγγειακά νοσήματα (ΚΚΝ) με κύριους εκπροσώπους τις Μυοκαρδιοπάθειες, τα Ηλεκτρικά Αρρυθμικά Σύνδρομα (Διαυλοπάθειες) και την ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων αρτηριών. Με εξαίρεση την ανώμαλη έκφυση των στεφανιαίων, τα νοσήματα αυτά οφείλονται συνήθως σε κάποια μετάλλαξη του γονιδιώματος και κληρονομούνται από τους γονείς στους απογόνους τους. Η ιδιομορφία των νοσημάτων αυτών είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν δίνουν ενοχλήματα με πρώτη και τελευταία εκδήλωση τον ΑΚΘ. **Το Δελτίο Υγείας με στοχευμένες ερωτήσεις από το Κληρονομικό και Ατομικό ιστορικό του αθλούμενου και με την βοήθεια του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) στοχεύει να ανιχνεύσει την πιθανή ύπαρξη ενός ΚΚΝ σε ένα αθλούμενο και με τον τρόπο αυτό να τον προφυλάξει από τον κίνδυνο ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου στον τόπο και χρόνο της άσκησης.**

10. Για τους αθλούμενους ηλικίας > των 35 ετών οι μελέτες έχουν δείξει ότι η κύρια αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου είναι η στεφανιαία νόσος, χωρίς όμως να αποκλείονται κάποιες από τις προαναφερθέντες κλινικές οντότητες³. Αυτός είναι και ο λόγος που απαιτείται Δοκιμασία Κοπώσεως στις ηλικίες αυτές με σκοπό την ανίχνευση ασυμπτωματικής στεφανιαίας νόσου που ενδεχόμενα μπορεί να προκαλέσει ένα οξύ στεφανιαίο επεισόδιο στις ηλικίες αυτές κατά την άσκηση.

Σκοπός - Έκδοση Δελτίων Υγείας ΚΟΑ

11. Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στήριξης του αθλητισμού του τόπου μας ήταν η υιοθέτηση του Δελτίου Υγείας από τον Αθλητικό κόσμο της Κύπρου (Ομοσπονδίες και Σωματεία).

12. Η έκδοση του Δελτίου Υγείας από Κρατικό όργανο και/ή υιοθέτηση του από τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία αποτελεί πρωτόγνωρη ενέργεια στον αθλητισμό όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του Παγκόσμιου Αθλητικού χώρου.

13. Κατά τα τελευταία 24 χρόνια έχουν εκδοθεί πέραν των 150.000 Δελτίων Υγείας, ενώ σήμερα εκδίδονται πέρα των 15.000 Δελτίων Υγείας το χρόνο λόγω αύξησης του πληθυσμού των αθλουμένων.

14. Αυτή τη στιγμή το Δελτίο Υγείας αποτελεί την ασφαλέστερη δικλείδα όσον αφορά στην υγεία όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό (σωματικά και πνευματικά). Εκδίδεται με την καθοδήγηση και τον έλεγχο μόνιμης Επιτροπής, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζει και η οποία οριοθετεί και εκσυγχρονίζει της μελλοντικές πολιτικές του

Δελτίου Υγείας βάσει της Διεθνούς βιβλιογραφίας και συστάσεων Επιστημονικών Εταιρειών.

15. Με βάση τα ανωτέρω, ο σκοπός των συγκεκριμένων ερωτήσεων για έκδοση Δελτίου Υγείας είναι η **άντληση των ελάχιστων βασικών πληροφοριών που θα θέτουν την υπόνοια ύπαρξης ενός ΚΚΝ και την ενημέρωση του αθλούμενου για τις ενδεδειγμένες προφυλάξεις ή αποφυγή συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας.** Για να γίνουν πιο κατανοητά τα ανωτέρω, αναφέρονται μερικά παραδείγματα:

(α) Σε περίπτωση που στο κληρονομικό ιστορικό αναφέρεται ΑΚΘ σε νεαρό άτομο της οικογένειας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποκρίβεται ένα ΚΚΝ που να έχει μεταβιβαστεί και σε άλλα μέλη της οικογένειας και δεδομένου ότι τα νοσήματα αυτά δεν δίδουν ενοχλήματα, το άτομο αυτό να ευρίσκεται σε κίνδυνο.

(β) Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις Στεφανιαίου επεισοδίου σε ηλικία < των 50 ετών σε άτομο της οικογένειας.

(γ) Η διαπίστωση ανοικτού ωοειδούς τρήματος σε ένα νεαρό αθλούμενο απαγορεύει αθλητική δραστηριότητα που περιλαμβάνει καταδύσεις. Οι στοχευμένες πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό στο Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ στοχεύουν ακριβώς στην υποβοήθηση του γιατρού να εντοπίσει υποκείμενο σοβαρό ασυμπτωματικό καρδιαγγειακό νόσημα και κατά συνέπεια την πρόληψη παθολογικών καταστάσεων που δεν θα αποκλείουν απαραίτητα την πλήρη ή με περιορισμό αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση.

15.1. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η έκδοση Δελτίου Υγείας είναι υποχρεωτική σε αθλητές/τριες των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων οι οποίοι προπονούνται και αγωνίζονται συστηματικά, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά.

15.2. Επιπλέον, οι συστάσεις του ΚΟΑ / ΑΣΥΑ προς όλο το κοινό που αθλείται και γυμνάζεται συστηματικά εκτός ομοσπονδιακού και σωματειακού αθλητισμού, είναι όπως προβαίνει στον απαραίτητο προαθλητικό ιατρικό και καρδιολογικό έλεγχο και υποβάλλει αίτηση για έκδοση Δελτίου Υγείας.

15.3. Ο προαθλητικός ιατρικός και καρδιολογικός έλεγχος και η έκδοση Δελτίου Υγείας όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες επιστολές μας, έχει καθοριστεί με βάση τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς επίσης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικάνικης καρδιολογικής εταιρείας⁴.

15.4. Τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανταγωνιστικού επιπέδου, είτε αυτές αφορούν σε αθλήματα που απαιτούν σωματική δραστηριότητα, είτε σε αθλήματα που δεν απαιτούν σωματική δραστηριότητα, εκθέτουν τον οργανισμό των ατόμων αυτών σε συνθήκες μέγιστης ή σχεδόν μέγιστης φόρτισης.

15.5. Ο χαρακτηρισμός μιας άσκησης ως «έντονης» δεν ταυτίζεται με τη μέγιστη προσπάθεια. Το επίπεδο της έντονης φόρτισης είτε σωματικής, είτε «πνευματικής», είτε ψυχοσωματικής, το ορίζει ο θεράπων ιατρός ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ατόμου που εξετάζει (βλέπε ατομικό, κληρονομικό ιστορικό, φυσική εξέταση κ.α, τα οποία απαιτούνται κατά τον πρωτοβάθμιο ιατρικό έλεγχο).

15.6. Τα παραπάνω τονίζονται ιδιαίτερα καθότι η «έντονη» άσκηση έχει συσχετιστεί με αυξημένο ποσοστό αιφνίδιου θανάτου, ειδικά σε άτομα άνω των 35 ετών με κύριο υπαίτιο την στεφανιαία νόσο.

Έκδοση Δελτίου Υγείας και ΚΥΣΟ

16. Όπως έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες επιστολές μας, για τις ιατρικές και καρδιολογικές εξετάσεις που απαιτούνται από τους αθλητές της ΚΥΣΟ, ο ΚΟΑ και το ΑΣΥΑ είχαν επανειλημμένες συναντήσεις **με την ΚΥΣΟ, στην παρουσία του Ιατρού Καρδιολόγου της**. Έγινε δηλαδή διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ στην παρουσία του επιστημονικού συνεργάτη τους, ο οποίος συμφώνησε και συναίνεσε πλήρως με την ακολουθούμενη στην περίπτωση αθλητών της ΚΥΣΟ διαδικασία.

17. Ως εκ τούτου, κατόπιν συζήτησης, μελέτης και **κοινής αποδοχής αποφασίστηκε** όπως για τους αθλητές άνω των 34 ετών που συμμετέχουν σε προπονήσεις και αγώνες της ΚΥΣΟ, **ελαχιστοποιηθούν και «περιοριστούν»** τα απαιτούμενα για σκοπούς της έκδοσης Δελτίων Υγείας, σε σχέση με αθλήματα που απαιτούν σωματική άσκηση.

18. Επιπρόσθετα αποφασίστηκε από κοινού όπως η διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Υγείας των αθλητών της ΚΥΣΟ αυξηθεί από τα δύο (2) έτη που ισχύει για αθλήματα με σωματική άσκηση, στα τρία (3) έτη.

19. Ως εκ των ανωτέρω, τα απαιτούμενα για έκδοση Δελτίων Υγείας των αθλητών της ΚΥΣΟ για τους αθλητές άνω των 35 ετών έχουν περιοριστεί στα απολύτως αναγκαία για την έκδοση Δελτίου Υγείας και είναι αναλογικά της επίτευξης του σκοπού για τα οποία απαιτούνται, ήτοι για την πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου (βλ. παρ. 11).

19.1. Για τους αθλητές μέχρι 34 ετών απαιτούνται οι ίδιες ιατρικές εξετάσεις όπως όλα τα αθλήματα καθότι όπως θα σας επεξηγήσουμε στη συνέχεια, το ΣΚΑΚΙ έχει κατηγοριοποιηθεί μέσα σε μελέτες και έρευνες ως έχων τους ίδιους βιοχημικούς, φυσικούς και άλλους παράγοντες όπως όλα τα αθλήματα.

20. Επίσης, ένεκα της τριετούς διάρκειας ισχύος του Δελτίου Υγείας για αθλητές της ΚΥΣΟ, οι αθλητές αυτοί υποβάλλονται στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις **κάθε τρία (3) χρόνια**.

21. Για την αξιολόγηση αίτησης για έκδοση Δελτίου Υγείας των αθλητών/τριων της ΚΥΣΟ άνω των 34 ετών απαιτούνται:

- Έντυπο ΚΟΑ «Αίτηση Ιατρικής Εξέτασης για Δελτίο Υγείας».
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) με γνωμάτευση από Καρδιολόγο Ιατρό.
- Γενικές Αναλύσεις Αίματος
- Βιοχημικές Αναλύσεις (μόνο την 1^η φορά για αθλητές άνω των 34 ετών)
- Ακτινογραφία θώρακα (μόνο την πρώτη φορά για αθλητές άνω των 34 ετών)
- Έκδοση για τρία (3) χρόνια.

21.1. Σε αντιδιαστολή, για αθλήματα που αφορούν σε σωματική άσκηση, η έκδοση Δελτίου Υγείας για ομοσπονδιακούς και σωματειακούς αθλητές άνω των 34 ετών προϋποθέτουν τα ακόλουθα αναλογικά της επίτευξης του σκοπού για τα οποία απαιτούνται, ήτοι για την πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου:

- Έντυπο ΚΟΑ

- ΗΚΓ με γνωμάτευση
- Δοκιμασία Κοπώσεως
- Γενικές Αναλύσεις Αίματος
- Βιοχημικές Αναλύσεις Αίματος (την 1η φορά άνω των 34 ετών)

Ακτινογραφία θώρακα (την 1η φορά άνω των 34 ετών) Έκδοση έως δύο (2) χρόνια.

Προαθλητικός Ιατρικός Καρδιολογικός Έλεγχος ΚΥΣΟ & Έκδοση Δελτίου Υγείας

22. Η επίδραση των Πνευματικών Αθλημάτων στο καρδιαγγειακό σύστημα κατά την διάρκεια ενός ,αγώνα και ιδιαίτερα του Σκακιού δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. Στην βάση δεδομένων MEDLINE PUB MED όπου καταχωρούνται όλες οι έγκυρες ιατρικές δημοσιεύσεις, σε αριθμό 36 εκατομμυρίων δημοσιεύσεων, υπάρχουν μόνο δύο αναφορές για την επίδραση του Σκακιού στο καρδιαγγειακό σύστημα. Οι μελέτες (συν. 1 & 2) αυτές τονίζουν την επίδραση του αθλήματος σε ένα απαιτητικό αγώνισμα σκακιού στην καρδιαγγειακή μεταβλητότητα -Heart Rate Variability (HRV)- Μεταβολές στο HRV μπορεί να προκαλέσουν αρρυθμίες και ιδιαίτερα κολπική μαρμαρυγή.

23. Με βάση δημοσιεύσεις στο Journal of Sports Medicine & Doping Studies (συν.3), έχουμε τονίσει με κίτρινο χρώμα τις διαπιστώσεις ότι οι βιοχημικές, φυσιολογικές, ψυχολογικές πτυχές και οι αλλαγές του κεντρικού νευρικού συστήματος σε άτομα που αγωνίζονται στο σκάκι είναι ισοδύναμες με όλα τα άλλα αθλήματα. Στην μελέτη γίνονται ειδικές αναφορές στο μεταβολικό φορτίο, στις μεταβολές της καρδιακής συχνότητας (HRV) και σε πολλές άλλες φυσιολογικές παραμέτρους.

23.1. Δημοσιεύσεις και άλλες βιβλιογραφικές πηγές για μελέτες και έρευνες σε αθλητές/τριες του Σκακιού (συν. 4 & 5), τις οποίες επίσης τονίσαμε με κίτρινο χρώμα.

24. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, το επίπεδο της «έντασης» και της φόρτισης των ατόμων κατά την άσκηση καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου ατόμου. Ακόμη και σε αθλητές ίδιου αθλήματος ή αθλητικής ομάδας η ίδια ένταση δεν έχει την ίδια φόρτιση στο καρδιαγγειακό σύστημα των ατόμων αλλά εξαρτάται από την φυσιολογία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.

25. Με βάση τα πιο πάνω, το άθλημα του σκακιού έχει ισοδύναμες βιοχημικές, φυσιολογικές και άλλες απαιτήσεις όπως όλα τα «κλασσικά» αθλήματα συμπεριλαμβανομένου και του ποδοσφαίρου και πρέπει να λαμβάνονται οι ανάλογες προφυλάξεις για την υγεία του σκακιστή σε ένα πνευματικά απαιτητικό αγώνισμα

26. Απόφασή Επιστημονικής Επιτροπής ΑΣΥΑ ημερ. 27.3.2024

Η Επιστημονική Επιτροπή ΑΣΥΑ αφού μελέτησε την επιστολή σας ημερ. 28.2.2024 και το περιεχόμενο αυτής, τις συνημμένες βιβλιογραφίες και δημοσιεύσεις καθώς επίσης και όλη την βιβλιογραφία και τα διεθνή πρότυπα που αφορούν τον προ - αθλητικό ιατρικό και καρδιολογικό έλεγχο, στην συνεδρία της ημερ. 27.3.2024 αποφάσισε την περαιτέρω **ελαχιστοποίηση των προ - απαιτούμενων για έκδοση Δελτίου Υγείας των Αθλητών/τριών της ΚΥΣΟ σε σχέση με τις υπόλοιπες αθλητικές Ομοσπονδίες ως ακολούθως:**

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	ΚΥΣΟ (αθλητές/τριες ΚΥΣΟ για όλες τις ηλικίες)	Αθλητικές Ομοσπονδίας αθλημάτων που απαιτούν σωματική δραστηριότητα		
		Αθλητές/τριες μέχρι 11 ετών	Αθλητές/τριες 11-34 ετών	Αθλητές/τριες 34 ετών και άνω
1. Έντυπο Ιατρικής Εξέτασης ΑΣΥΑ ΚΟΑ «Αίτηση για έκδοση Δελτίου Υγείας» (πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα Ιατρό και τον αιτητή)	V	V	V	V
2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα σε ηρεμία (υπογραφή και σφραγίδα Ιατρού)	V	V	V	V
3. Δοκιμασία Κοπώσεως - Stress test				V
4. Υπερηχο-καρδιογράφημα Echocardiogram	Σε περίπτωση που διαγνωστεί φύσημα καρδιάς	Σε περίπτωση που διαγνωστεί φύσημα καρδιάς	Σε περίπτωση που διαγνωστεί φύσημα καρδιάς	Σε περίπτωση που διαγνωστεί φύσημα καρδιάς
5. Γενική Ανάλυση Αίματος - Full Blood Count	V (για αθλητές/τριες άνω των 11 ετών)		V	V
6. Βιοχημικές Αναλύσεις Αίματος (μόνο κατά την υποβολή αίτησης την 1 ^η φορά)			V	V
7. Ομάδα Αίματος (μόνο κατά την υποβολή αίτησης τη 1 ^η φορά)	V	V	V	V
8. Ακτινογραφία θώρακα και γνωμάτευση (μόνο κατά την υποβολή αίτησης για 1 ^η φορά)				V
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ	Έως 3 έτη	Έως 3 έτη	Έως 3 έτη	Έως 2 έτη

Νοείται ότι:

1. Η απόφαση του ΑΣΥΑ αφορά μόνο τις προ - απαιτούμενες ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις που αφορούν τον προ - αθλητικό ιατρικό και καρδιολογικό Έλεγχο των Αθλητών/τριων της ΚΥΣΟ για έκδοση Δελτίου Υγείας και όχι άλλα στοιχεία και δεδομένα που σχετίζονται με την νομοθεσία και τους κανονισμούς έκδοσης Δελτίου Υγείας.
2. Στους Αθλητές/τριες της ΚΥΣΟ άνω των 34 ετών το Έντυπο ΚΟΑ και το Ηλεκτροκαρδιογράφημα σε ηρεμία θα συμπληρώνεται από Καρδιολόγο Ιατρό.
3. Η διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Υγείας των αθλητών/τριων της ΚΥΣΟ θα έχει ισχύ για 3 έτη, εκτός των περιπτώσεων όπου κατά την δευτεροβάθμια αξιολόγηση τους από τις Ιατρικές Επιτροπές Αξιολόγησης διαπιστωθούν παθολογικά ευρήματα για τα οποία θα πρέπει ο αθλητής/τρια να προσκομίσει συμπληρωματικές ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Ιατρικής Επιτροπής.

4. Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση για τους αθλητές της ΚΥΣΟ απαιτείται κάθε τρία (3) χρόνια η υποβολή αίτησης για έκδοση Δελτίου Υγείας με την προσκόμιση του Εντύπου «Ιατρικής Εξέτασης για Έκδοσή Δελτίου Υγείας», Ηλεκτροκαρδιογραφήματος με γνωμάτευση του εξετάζοντος Ιατρού και Γενικές Αναλύσεις Αίματος.

Καταληκτικά

27. Τα ερωτήματα και οι εξετάσεις που ζητούνται για την έκδοση Δελτίου Υγείας είναι αναλογικά του σκοπού των οποίων εξυπηρετούν, ήτοι την ανίχνευση καρδιαγγειακών προβλημάτων που ενδεχόμενα να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή ενός αθλητή και την πρόληψη του ΑΚΘ. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι του είδους του αθλήματος - πνευματικό ή σωματικό.

28. Η υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Υγείας αφορά μόνο στους αθλούμενους που συμμετέχουν σε αγώνες και προπονήσεις των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων.

29. Ο ΚΟΑ/ΑΣΥΑ από την 01/01/2019 έως τις 31/12/2023 αξιολόγησε 62.511 αιτήσεις για έκδοση Δελτίου Υγείας και σήμερα βρίσκονται σε ισχύ 48.112 Δελτία Υγείας.

30. Τόσο η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία όσο και η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία συμφωνούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη ελέγχου των αθλητών /αθλουμένων τόσο για ιατρικούς όσο και για ηθικούς και νομικούς λόγους⁵.

31. Την πιο πάνω θέση υποστηρίζουν με τις ενέργειες και τις πράξεις τους διαχρονικά, τόσο η ΕΕ ΑΣΥΑ και τα μέλη του ΙΑΕ όσο και όλα τα μέλη που του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Βιβλιογραφία:

1. Corrado, D., Basso, C., Rizzoli, G et al. Does sports activity enhance the risk of sudden death in adolescents and young adults? J Am Coll Cardiol 2003; 42: 1959- 63
2. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, Tierney DM, Mueller FO. Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation. 2009;119:1085-1092
3. Maron BJ, Epstein SE, Roberts WC. Causes of sudden death in competitive athletes. J Am Coll Cardiol. 1986;7:204-214
4. Maron, BJ., Thompson, P.D., Ackerman, MJ. et al. Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: endorsed by the American College of Cardiology Foundation. Circulation 2007; 115:1643-55.
5. Corrado, D., Pelliccia, A., Bjornstad, H.H. et al. Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol. Eur Heart J 2005; 26: 516-24»

Στην πιο πάνω επιστολή επισυνάφθηκαν τα επιστημονικά άρθρα με τους κάτωθι τίτλους:

1. The stress of chess players as a model to study the effects of psychological stimuli on physiological responses: an example of substrate oxidation and heart rate variability in man
2. Differences Between High vs. Low Performance Chess Players in Heart Rate variability During Chess Problems
3. Biochemistry and Psychology of Chess and Classical Physical ExerciseQ Concurring or Conflicting Evidence?
4. Arrhythmia risk assessment using heart rate variability parameters in patients with frequent ventricular ectopic beats without structural heart disease.
5. Effects of Official Chess Competition on Salivary Cortisol and Mood Swings in Adolescent Girls: A Win-Loss Approach

B. Νομικό Πλαίσιο:

12.1. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού,

«1) «*δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα*»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»): το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

2) «*επεξεργασία*»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, (...)

7) «*υπεύθυνος επεξεργασίας*»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους (...)

15) «*δεδομένα που αφορούν την υγεία*»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης

της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του»

12.2. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού,

«Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»)

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 («λογοδοσία»).

12.3. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού:

1. Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,
δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,
ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.
Το στοιχείο στ) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία που διενεργείται από δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

12.4. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού:

«Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους προβλέπει ότι η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες

εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,

δ) η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων,

ε) η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων,

η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δύναμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυννοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, ή

ι) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη

διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο η), όταν τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς ή από άλλο πρόσωπο το οποίο υπέχει επίσης υποχρέωση τήρησης του απορρήτου βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς, όσον αφορά την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν την υγεία.»

12.5. Σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Κανονισμού, «2. Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες διορθωτικές εξουσίες:

α) να απευθύνει προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία ότι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανόν να παραβαίνουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού,

β) να απευθύνει επιπλήξεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία όταν πράξεις επεξεργασίας έχουν παραβεί διατάξεις του παρόντος κανονισμού,

γ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία να συμμορφώνεται προς τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

δ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία να καθιστούν τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν χρειάζεται, με συγκεκριμένο τρόπο και εντός ορισμένης προθεσμίας,

ε) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ανακοινώνει την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων,

στ) να επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης της επεξεργασίας,

ζ) να δίνει εντολή διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 16, 17 και 18 και εντολή κοινοποίησης των ενεργειών αυτών σε αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 και του άρθρου 19,

η) να αποσύρει την πιστοποίηση ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να αποσύρει ένα πιστοποιητικό εκδοθέν σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να μην εκδώσει πιστοποίηση, εφόσον οι απαιτήσεις πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον,

θ) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 83, επιπλέον ή αντί των μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης περίπτωσης,

ι) να δίνει εντολή για αναστολή της κυκλοφορίας δεδομένων σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό.»

12.6. Σύμφωνα με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 (41/1969):

«5.-(1) Σκοπός του Οργανισμού είναι η προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της νήσου, η καλλιέργεια και ανάπτυξης του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος παρά τω λαώ, η εντός του πλαισίου των υφισταμένων σχέσεων μετά εξωκυπριακών αρχών και οργανώσεων αθλητική προβολή της νήσου εις το εξωτερικόν και η εν συνεργασία μετά των αρχών και οργανώσεων τούτων, βελτίωσις της θέσεως αυτής εις την διεθνή αθλητικήν κίνησην, καθώς και η προώθηση σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό.

(2) Προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού, το Διοικητικόν Συμβούλιον, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κέκτηται αρμοδιότητα όπως:

(...)

(ιστ) συνιστά οιασδήποτε επιτροπάς, σώματα ή όργανα των οποίων η σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή.

(ιζ) αναθέτη εις οιαδήποτε υπ' αυτού συσταθείσαν επιτροπήν, όργανον ή σώμα την άσκησιν οιασδήποτε των υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων.

(...)

(κ) καθορίζη τα της εκδόσεως δελτίων υγείας των αθλουμένων και προνοή περί της ακολουθουμένης εν γένει διαδικασίας ιατρικής εξετάσεως εκάστου αθλουμένου μέλους, αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου:

Νοείται ότι το δελτίο υγείας σε ουδεμίαν περίπτωση εκδίδεται, εάν ο αθλούμενος είναι στρατεύσιμος ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν και κατέχει, δυνάμει του Νόμου αυτού, προσωρινό απολυτήριο, είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί δελτίο υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν, και ακολούθως του χορηγήθηκε προσωρινό απολυτήριο για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη, η πράξη έκδοσης του δελτίου υγείας ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή, είτε από την ημερομηνία έναρξης της

ισχύος του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2021 είτε από την ημερομηνία τυχόν μεταγενέστερης από αυτή προσωρινής απόλυσης του στρατεύσιμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η πράξη ανάκλησης, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη επιφύλαξη, κοινοποιείται αμέσως τόσο στον αθλούμενο στρατεύσιμο όσο και στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και αθλητικό σωματείο στα οποία αυτός ανήκει.»

Γ. Σκεπτικό

13. Σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 (41/1969), σκοπός του Οργανισμού, είναι «*η προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της νήσου, η καλλιέργεια και ανάπτυξεις του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος παρά τω λαώ, η εντός του πλαισίου των υφισταμένων σχέσεων μετά εξωκυπριακών αρχών και οργανώσεων αθλητική προβολή της νήσου εις το εξωτερικόν και η εν συνεργασία μετά των αρχών και οργανώσεων τούτων, βελτίωσις της θέσεως αυτής εις την διεθνή αθλητικήν κίνησιν, καθώς και η προώθηση σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό*».

14. Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, δυνάμει του άρθρου 5(2) του Ν. 41/1969, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ έχει αρμοδιότητα, ανάμεσα σε άλλες, να καθορίζει τα όσα απαιτούνται για την έκδοση των Δελτίων Υγείας των αθλουμένων και της διαδικασίας των ιατρικών εξετάσεων που θα πρέπει να ακολουθείται.

15. Βάσει του ίδιου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ασκώντας τις εξουσίες του, δύναται να συστήσει επιτροπή, σώμα ή όργανο στην οποία να αναθέσει την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων του. Βάσει αυτών των προνοιών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ αποφάσισε την σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής «Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ)».

16. Σύμφωνα και με τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΟΑ, «*Οι όροι εντολής και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ΑΣΥΑ έχουν καθοριστεί με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2011. Συνοπτικά αναφέρονται οι πιο κάτω:*

- 1. Το ΑΣΥΑ είναι ο αρμόδιος φορέας που επιλαμβάνεται θέματα προληπτικής εξέτασης των αθλουμένων με απώτερο σκοπό την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου και είναι υπεύθυνο για την έκδοση δελτίου υγείας με την επωνυμία Δελτία Υγείας ΑΣΥΑ.*
- 2. Το ΑΣΥΑ είναι η αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού, για τον καθορισμό της απαιτούμενης διαδικασίας της ιατρικής εξέτασης της έκδοσης του δελτίου υγείας.*
- 3. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης εξελίξεων και των πρακτικών που ακολουθούνται στην επιστήμη της Υγείας των Αθλουμένων ανα το παγκόσμιο και ιδιαίτερα*

του τομέα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και πρόληψης της υγείας των αθλουμένων και εισηγείται για τροποποιήσεις στις διαδικασίες έκδοσης Δελτίου Υγείας όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο.»

17. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω πληροφορίες, δυνάμει του Άρθρου 4 του Κανονισμού, η συλλογή, αποθήκευση και οποιαδήποτε άλλη χρήση ιατρικών δεδομένων ή άλλων προσωπικών δεδομένων των αθλητών κατά την έκδοση των Δελτίων Υγείας αποτελεί πράξη επεξεργασίας. Ο Καταγγέλλων, όπως και όλοι οι αθλούμενοι, ως τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας συνιστούν τα υποκείμενα των δεδομένων και αντίστοιχα ο ΚΟΑ, ως ο οργανισμός που καθορίζει το σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας, τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

18. Παρόλη την νομιμότητα της έκδοσης των Δελτίων Υγείας, αφού αυτή εδράζεται στο άρθρο 5 του Ν. 41/1969, οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας διενεργείται στα πλαίσια της έκδοσης αυτής θα πρέπει να διέπεται από τις Αρχές επεξεργασίας δεδομένων όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού. Ανάμεσα σε αυτές, η αρχή του περιορισμού του σκοπού και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (Άρθρο 5(1)(β) και (γ) του Κανονισμού). Δυνάμει αυτών, τα ιατρικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται για την έκδοση των Δελτίων Υγείας θα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς, να περιορίζονται στο αναγκαίο και να είναι κατάλληλα και συναφή του σκοπού. Υπογραμμίζω ότι ο καθορισμός γενικών σκοπών δεν νομιμοποιεί αυτομάτως και την υπερβολική συλλογή δεδομένων.

19. Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, για την αξιολόγηση της πιο πάνω αρχής ζήτησα από τον ΚΟΑ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να με ενημερώσει για το σκοπό έκδοσης των Δελτίων Υγείας. Σύμφωνα με τις τελικές θέσεις της Επιτροπής ΑΣΥΑ που υποβλήθηκαν ενώπιόν μου *«Σκοπός του Δελτίου Υγείας και των εξετάσεων που διενεργούνται προς έκδοση του είναι η πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου σε αθλούμενους. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή με περιορισμό αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση.»*

20. Η αναγκαιότητα της πρόληψης του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου σε αθλούμενους, αιτιολογήθηκε βάσει συγκεκριμένης μελέτης (Corrado και των συνεργατών του), σύμφωνα με την οποία έχει υπολογιστεί ότι η συμμετοχή σε αγωνιστικό αθλητισμό αυξάνει κατά 2.5 φορές τον κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε σχέση με άτομα που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό.

21. Στις αρχικές δηλώσεις του ο ΚΟΑ, είχε αναφέρει ότι η συλλογή των ιατρικών δεδομένων για την έκδοση του Δελτίου Υγείας, έχει ως σκοπό την ανίχνευση προβλημάτων υγείας, τα οποία δυνατόν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των αθλουμένων, όχι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά γενικά κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας, σκοπό τον οποίο είχα κρίνει στην εκ πρώτης όψεως Απόφασή μου αρκετά ευρύ και γενικό. Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις μου, όπως φαίνεται και ανωτέρω, ο σκοπός της έκδοσης των Δελτίων περιορίστηκε στην πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου στους αθλουμένους.

22. Όπως είχα επισημάνει και στην εκ πρώτης όψεως Απόφασή μου, εφόσον η έκδοση Δελτίων Υγείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλουμένων σε διοργανώσεις των αναγνωρισμένων Ομοσπονδιών τους και αποσκοπεί στην προφύλαξη της υγείας των αθλητών, αυτή θα πρέπει να είναι ανάλογη του αθλήματος. Λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των 5 άλλων εποπτικών αρχών, στις οποίες απευθύνθηκα είχα καταλήξει στην εν λόγω Απόφασή μου ότι η αναγκαιότητα της έκδοσης του Δελτίου Υγείας για τους αθλητές στο σκάκι θα έπρεπε να επαναξιολογηθεί και η αναλογικότητα των συλλεχθέντων δεδομένων να τεκμηριωθεί καταλλήλως.

23.1. Έχοντας υπόψη τις πιο πάνω υποδείξεις μου η Επιτροπή ΑΣΥΑ, με συγκεκριμένες αναφορές σε μελέτες επισήμανε ότι -

- έχει τονιστεί η επίδραση του αθλήματος σε ένα απαιτητικό αγώνισμα σκακιού στην καρδιαγγειακή μεταβλητότητα, μεταβολές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν αρρυθμίες και ιδιαίτερα κολπική μαρμαρυγή,
- οι βιοχημικές, φυσιολογικές, ψυχολογικές πτυχές και οι αλλαγές του κεντρικού νευρικού συστήματος σε άτομα που αγωνίζονται στο σκάκι είναι ισοδύναμες με όλα τα άλλα αθλήματα,
- τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανταγωνιστικού επιπέδου, είτε αυτές αφορούν σε αθλήματα που απαιτούν σωματική δραστηριότητα, είτε σε αθλήματα που δεν απαιτούν σωματική δραστηριότητα, εκθέτουν τον οργανισμό των ατόμων αυτών σε συνθήκες μέγιστης ή σχεδόν μέγιστης φόρτισης,
- το επίπεδο της «έντασης» και της φόρτισης των ατόμων κατά την άσκηση καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου ατόμου. Ακόμη και σε αθλητές ίδιου αθλήματος ή αθλητικής ομάδας η ίδια ένταση δεν έχει την ίδια φόρτιση στο καρδιαγγειακό σύστημα των ατόμων, αλλά εξαρτάται από την φυσιολογία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά,
- η «έντονη» άσκηση έχει συσχετιστεί με αυξημένο ποσοστό αιφνίδιου θανάτου, ειδικά σε άτομα άνω των 35 ετών με κύριο υπαίτιο την στεφανιαία νόσο,

αιτιολογώντας την αναγκαιότητα ανίχνευσης προβλημάτων υγείας στους σκακιστές για την προφύλαξη της υγείας τους, μέσω της έκδοσης των Δελτίων Υγείας.

23.2. Για την ικανοποίηση της αρχής της αναλογικότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ προχώρησε σε ελαχιστοποίηση των προαπαιτούμενων εξετάσεων για έκδοση Δελτίου Υγείας από τους αθλητές της ΚΥΣΟ (Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας) όπως φαίνεται και στον πίνακα που παρατίθεται στα Περιστατικά της παρούσας Απόφασης, τροποποιώντας και την διάρκεια ισχύος του. Προς αιτιολόγηση της συμπλήρωσης του Εντύπου Ιατρικής Εξέτασης για έκδοση Δελτίου Υγείας, η Επιτροπή ΑΣΥΑ επεξήγησε πως οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται με την βοήθεια του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στοχεύουν στην ανίχνευση της ύπαρξης κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων του αθλούμενου έτσι ώστε να τον προφυλάξουν από τον κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου στον τόπο και χρόνο της άσκησης, προς επίτευξη επομένως του σκοπού έκδοσης του Δελτίου Υγείας.

24. Παρόλο που η επίδραση των πνευματικών αθλημάτων στο καρδιαγγειακό σύστημα, ιδιαιτέρως για το σκάκι, δεν έχει μελετηθεί σε βάθος και είναι μεμονωμένος ο αριθμός των μελετών που εξετάζει την επίδραση του σκακιού στο καρδιακό σύστημα, ως σημειώνει και η Επιτροπή ΑΣΥΑ, **κατά την άποψη μου αυτό δεν αιτιολογεί την εξολοκλήρου κατάργηση της έκδοσης του Δελτίου Υγείας για το συγκεκριμένο άθλημα.**

25. **Σεβόμενη την ιατρική πτυχή του θέματος και το γεγονός ότι η Επιτροπή ΑΣΥΑ αιτιολόγησε τις θέσεις της,** παρέχοντας συγκεκριμένες επεξηγήσεις και επιστημονικές αναφορές, παρουσιάζοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνει αναγκαία την έκδοση Δελτίων Υγείας στους σκακιστές, αλλά και **τροποποίησε τα προαπαιτούμενα για την έκδοση Δελτίου Υγείας των αθλητών της ΚΥΣΟ, δεν κρίνω αναλογική οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των ιατρικών δεδομένων που συλλέγονται.** Υπογραμμίζω πως εφόσον η έκδοση των Δελτίων Υγείας εμπίπτει και σε θέματα προσωπικών δεδομένων, αφού τα δεδομένα υγείας που συλλέγονται και αξιολογούνται αποτελούν ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η επεξεργασία γενικά απαγορεύεται και νομιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο ΚΟΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να παρακολουθεί τις ιατρικές εξελίξεις και να επικαιροποιεί/τροποποιεί αναλόγως τις σχετικές με την έκδοση Δελτίων Υγείας διαδικασίες του, έτσι ώστε οι ιατρικές εξετάσεις ή/και οποιοσδήποτε ιατρικός έλεγχος για την έκδοση των Δελτίων Υγείας να καθορίζεται με γνώμονα το άθλημα για το οποίο απευθύνεται/ στο οποίο αφορά.

26. Στην πιο πάνω κατάληξή μου προσμετρώ επίσης την παρουσία των Ομοσπονδιών και των Ιατρών Καρδιολόγων τους στις συναντήσεις που αφορούσαν στον καθορισμό των προαπαιτούμενων εξετάσεων κατά την υποβολή της αίτησης έκδοσης Δελτίων Υγείας και κρίνω σημαντικό όπως οι απόψεις τους και οι εισηγήσεις τους επί του θέματος αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή ΑΣΥΑ και κατ' επέκταση από τον ΚΟΑ. Όσον αφορά στους ισχυρισμούς του Καταγγέλλοντος, περί συνυπολογισμού κι

άλλων παραγόντων στην απόφαση της Ομοσπονδίας να συμμορφωθεί πέραν της χρησιμότητας των συγκεκριμένων ελέγχων για το σκάκι (ισχυρισμός ο οποίος δεν τεκμηριώθηκε περαιτέρω), είμαι της άποψης ότι εάν και εφόσον οι θέσεις της Ομοσπονδίας τεκμηριώνονται καταλλήλως θα πρέπει να εισακούονται.

27. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, στην εξέταση του θέματος αφενός έχουν εμπλακεί ειδικοί επιστήμονες, διαφορετικοί κάθε φορά (και από το εμπλεκόμενο πρόσωπο (ΚΟΑ) αλλά και από τις ομοσπονδίες) οι οποίοι αξιολόγησαν την αναγκαιότητα της εξέτασης των αθλουμένων, αφετέρου κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ζήτησα και έλαβα τις θέσεις και απόψεις του ΚΟΑ ως υπεύθυνου επεξεργασίας. Ως εκ τούτου δεν έκρινα αναγκαία την λήψη άλλης γνωμάτευσης από εξωτερικό εμπειρογνώμονα.

28. Όπως έχω σημειώσει και στην εκ πρώτης όψεως Απόφαση μου, όσον αφορά στην θέση της Επιτροπής ΑΣΥΑ ότι -

- η διαδικασία εμπίπτει στις πρακτικές εξάσκησης της Ιατρικής,
- η καταγραφή των παθολογικών ευρημάτων διαμορφώνει Τράπεζα δεδομένων για σκοπούς έρευνας προς όφελος της αξιόπιστης στατιστικής και διαμόρφωσης μητρώου περιστατικών, τηρώντας τους κανόνες της επιτροπής βιοηθικής,
- η άντληση παθολογικών δεδομένων θα συμβάλει στην βελτίωση των πρακτικών που ακολουθούνται στην πρόληψη του ΑΚΘ αλλά και την μεγιστοποίηση των συνθηκών διασφάλισης της ζωής των πολιτών/αθλουμένων,

τονίζω ότι παρόλο που τα πιο πάνω συνιστούν νόμιμο σκοπό επεξεργασίας, συμβατό με τον αρχικό σκοπό που έχει καθοριστεί (Άρθρο 5(1)(β) του Κανονισμού), η επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας συνιστά περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται θα πρέπει να είναι ανάλογα του σκοπού που έχει αρχικώς καθοριστεί.

29. Σχετικό είναι και το παρακάτω απόσπασμα από το «*EDPB Document on response to the request from the European Commission for clarifications on the consistent application of the GDPR, focusing on health research*» το οποίο παρόλο που αφορά παρόχους περίθαλψης υγείας, θεωρώ ότι μπορεί αναλογικά να χρησιμοποιηθεί και στην πιο πάνω θέση της Επιτροπής ΑΣΥΑ:

«Q7. *If a health care provider collected health data from patients and wishes to use those data for a scientific research project, to what extent would this be considered compatible further processing?*

22. *When further processing of health data for scientific research purposes relies on the presumption of compatible use (Article 5(1)(b) GDPR), the controller will have to take Article 9 GDPR into account as well. It could very well be that the exemption to the prohibition on the processing of health data the health care provider relied on for the original purpose does not extend to or does not cover the processing of health data for scientific research purposes. For instance, if the exemption in MS law only allows for the*

processing of health data by the health care provider in order to provide health care of medical treatments (Article 9(2)(h) GDPR), the health care provider would still need to rely on an exemption based on Union or MS law as required in Article 9(2) GDPR for the processing of health data for scientific research purposes.»

30. Όσον αφορά στις δικλείδες ασφαλείας που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, χρήσιμη είναι η έκθεση EDPS/2019/02-08 με θέμα: «Study on the appropriate safeguards under Article 89(1) GDPR for the processing of personal data for scientific research».

31. Όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με την στρατιωτική θητεία των αθλουμένων την οποία θίγει ο Καταγγέλλων στην τελευταία επιστολή του, αυτή αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο βασίζεται εξ ολοκλήρου στην νομική πρόνοια που περιέχεται στον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο του 1969 (41/1969). «*Νοείται ότι το δελτίο υγείας σε ουδεμίαν περίπτωση εκδίδεται, εάν ο αθλούμενος είναι στρατεύσιμος ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν και κατέχει, δυνάμει του Νόμου αυτού, προσωρινό απολυτήριο, είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (1/5) είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία (...)*».

32. Η πιο πάνω πρόνοια ορίζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον ΚΟΑ. Για το εν λόγω θέμα είχα δώσει προηγουμένως σχετική καθοδήγηση στο Υπουργείο Άμυνας και στον ΚΟΑ, σχετικά με την τεχνική λύση που θα εφαρμοζόταν έτσι ώστε η Εθνική Φρουρά να παρέχει στον ΚΟΑ μόνο την απαραίτητη πληροφόρηση που απαιτεί το άρθρο 5(2) του Ν. 41/1969, την υλοποίηση εκτίμησης αντικτύπου, την διασφάλιση ότι η Εθνική Φρουρά θα παρέχει στον ΚΟΑ μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των εκ του Νόμου υποχρεώσεων του και την συμπερίληψη σχετικού κειμένου ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων. Συνεπώς, το θέμα δεν θα επανεξεταστεί στην παρούσα καταγγελία.

33. Τέλος, ο ισχυρισμός του Καταγγέλλοντος για εξαναγκασμό λήψης δεδομένων θεωρώ ότι εξετάζεται άμεσα από την επαναξιολόγηση της αναλογικότητας της έκδοσης των Δελτίων Υγείας.

Δ. Κατάληξη

34. Από τα ενώπιον μου στοιχεία, την ανωτέρω ανάλυση, τις τροποποιήσεις στις οποίες προέβη ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μετά την έκδοσή της εκ πρώτης όψεως Απόφασής μου και με βάση τις εξουσίες που μου παρέχονται από το Άρθρο 58 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 καταλήγω ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της εκ πρώτης όψεως Απόφασής μου.

35. Λαμβάνοντας υπόψιν μελλοντικές ιατρικές εξελίξεις που δυνατόν να τροποποιήσουν τα όσα έχουν αναφερθεί από την Επιτροπή ΑΣΥΑ, συστήνω στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, όπως παρακολουθεί το εν λόγω θέμα και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργεί να ικανοποιούν τις Αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σε περίπτωση που μελλοντικά χρειαστεί, επιφυλάσσομαι να επέμβω και να επανεξετάσω το θέμα.

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

12 Ιουλίου 2024